CLINIC A

定量脳波・事象関連電位 レポート

Quantitative EEG and ERP report

日本語版は後の市場向けです。要約とVCPTの文は認証機関の判断を待ちます。
Japanese: later market; summary and VCPT sentences subject to the certification body.

[クリニック画像のプレースホルダー：記録の様子と電極配置] Clinic image placeholder: recording set-up and electrode montage

[クリニック画像のプレースホルダー：スペクトルの例と帯域の凡例] Clinic image placeholder: example spectrum and band legend

氏名	Mock Patient 042		
症例コード	MOCK-042	**生年月日** **性別**	2016年1月1日 女
検査日	2026年9月15日	**年齢** **過去の測定**	10 歳 2026年3月12日

ソフトウェア	V4 mockup 0.1
基準データ	Mock norms 2026.1 (synthetic)
記録システム	Mitsarアンプ、WinEEGファイル（モックアップ用の表記）
レポート	R-MOCK-042-0915 v1 · 下書き（未発行）

1. 要約：Summary

認証機関の判断待ち / Subject to the certification body

本測定で印の付いた年齢基準からの偏差のうち、最も大きい項目は次のとおりです：開眼時のシータ相対パワー：O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)、Pz (z = −4.0)／閉眼時のシータ相対パワー：O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)、Pz (z = −4.1)／開眼時のSMR非対称指数：C3-C4 (z = 4.2)／閉眼時のSMR非対称指数：C3-C4 (z = 4.2)／閉眼時のベータ1コヒーレンス：T3-C3 (z = 4.1)、C3-T5 (z = 4.1)、T3-T5 (z = 4.0)、T5-O1 (z = 4.0)、P3-O1 (z = 4.0)、C3-P3 (z = 3.9)、T5-P3 (z = 3.8)／開眼時のベータ1コヒーレンス：Fp2-T4 (z = −3.9)、T3-T5 (z = 3.9)、T5-O1 (z = 3.9)、P3-O1 (z = 3.9)、T3-C3 (z = 3.8)、C3-P3 (z = 3.8)、C3-T5 (z = 3.7)、T5-P3 (z = 3.7)／Go試行のP1潜時：O1 (z = 3.7)、O2 (z = 3.7)。 SUM-2

この一覧は、次の解析で印の付いた値を|z|の大きい順に並べます：絶対パワーと相対パワー、1 Hz帯域ごとのマップ、アルファピーク周波数、シータ/ベータ比、前頭部アルファ非対称指数、非対称マップ、電極ペアごとのコヒーレンス、ERPピークの振幅と潜時、VCPT課題の結果。上位5項目と、3 z以上の印の付いたすべての値を示します。0.5 Hzごとのスペクトル（基準と比較した曲線として表示）と、確認待ちのグローバルコヒーレンスは順位付けの対象外です。 SUM-RULE-2

本測定で印の付いた値：帯域パワー 456中6、1 Hz帯域マップ 1102中0、アルファピークと比・指数 6中0、非対称マップ 96中2、コヒーレンス 2052中15、ERPピーク 21中2、VCPT課題 4中0。 SUM-COUNT-1

2. 信号品質と処理：Signal quality and processing

開眼時：アーチファクト除去後、180秒中164秒を解析しました。 Q-DUR-1

閉眼時：アーチファクト除去後、180秒中171秒を解析しました。 Q-DUR-1

VCPT：アーチファクト除去後、1220秒中1168秒を解析しました。 Q-DUR-1

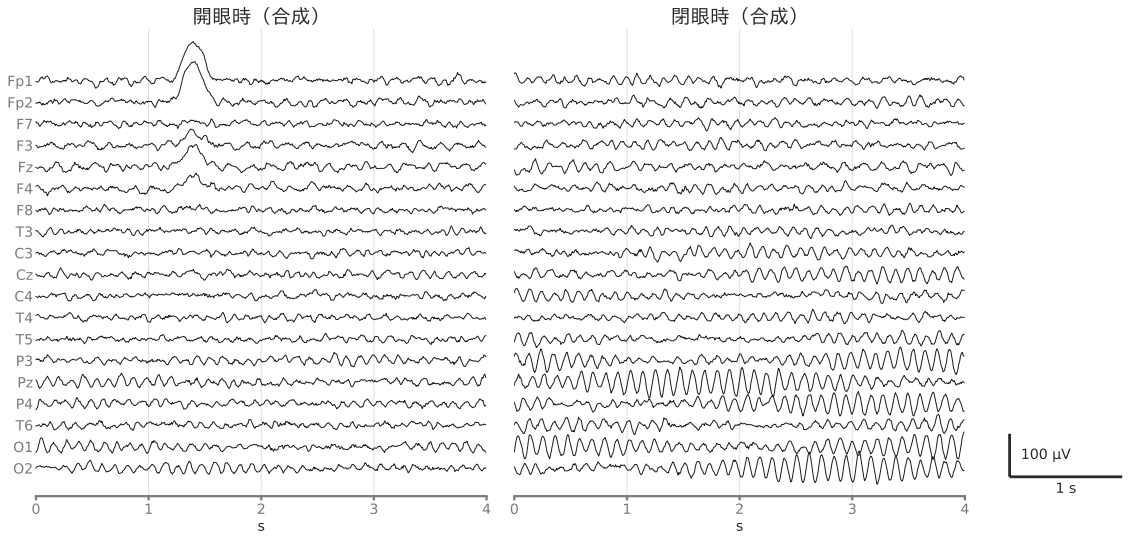
採用したVCPT試行数：Go 95、NoGo 92、Ignore 93、Novelty 95（各100試行中）。 Q-TRIALS-1

アーチファクト除去は臨床医が変更しました：自動クリーニングは成分6（筋電、左側頭部）の除去を提案しましたが、保持しました。19個中2個の成分を除去しました。 Q-ICA-MAN-1

解析区間は、臨床医が提案どおりに確認しました。 Q-SEG-AUTO-1

閉眼時のアルファピーク周波数（後部電極の平均）：提案値9.2 Hzを臨床医が変更せずに確認しました。印なし（z = 0.0）。 MK-AUTO-1

3. 脳波原波形（抜粋）：Raw EEG excerpt



合成信号（実際の記録ではありません）：解析区間の最初の4秒、開眼時と閉眼時、平均基準、19チャンネル。スケール：100 µVと1秒。

4. 既往歴・問診：Anamnesis

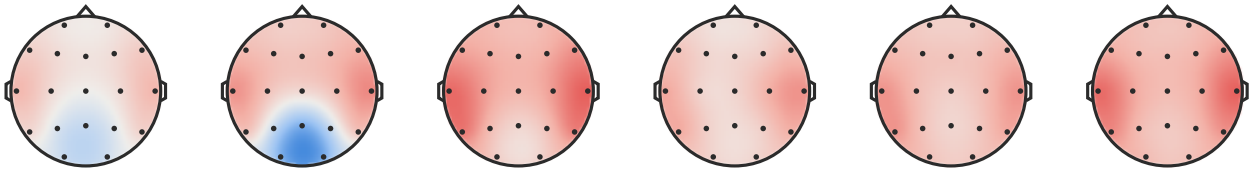
臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

5. スペクトルとマップ：Spectra and maps

開眼時

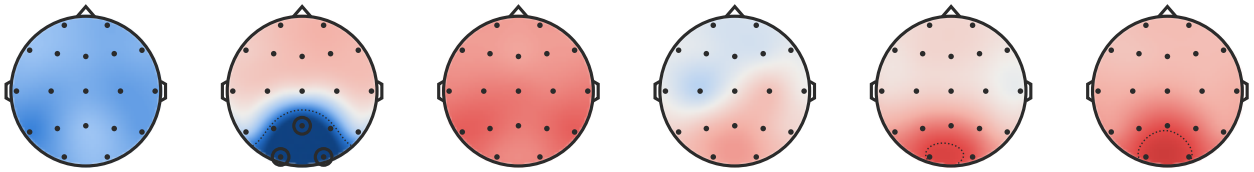
絶対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



相対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



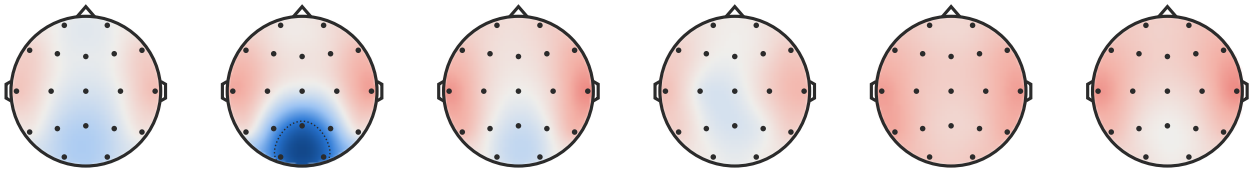
開眼時のシータ帯域の相対パワーは、Pz (z = −4.0)、O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)で年齢基準より低い値です。 SP-REL-1

開眼時のアルファピーク周波数は9.2 Hzで、印は付いていません（z = 0.1）。 APF-IN-2

閉眼時

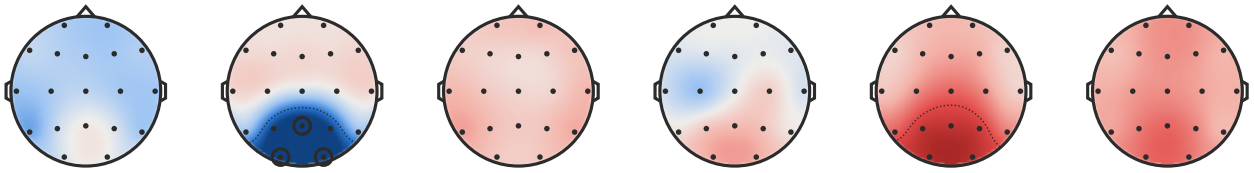
絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



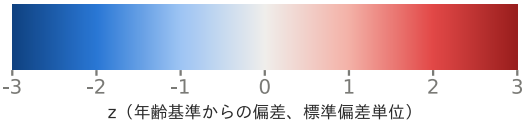
相対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



閉眼時のシータ帯域の相対パワーは、Pz (z = −4.1)、O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)で年齢基準より低い値です。 SP-REL-1

閉眼時のアルファピーク周波数は9.2 Hzで、印は付いていません（z = 0.0）。 APF-IN-2



輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

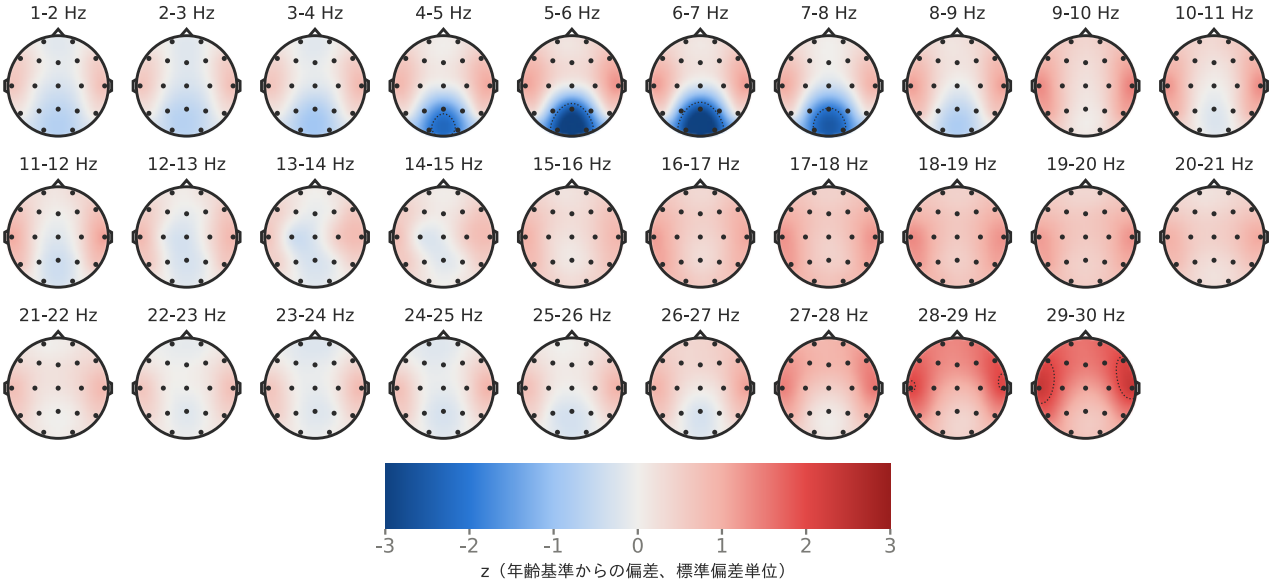
臨床医コメント：Clinician's comment

臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

6. 1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）：Maps per 1 Hz band (absolute power, z)

閉眼時

1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）, 閉眼時

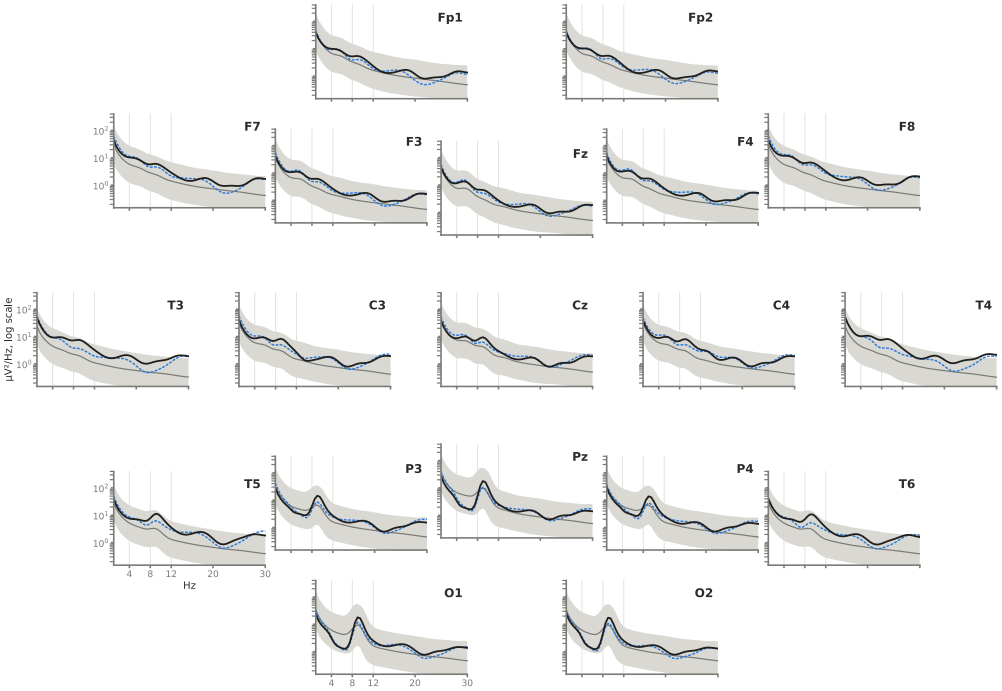


輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

7. 電極ごとの絶対スペクトル：Absolute spectra per electrode

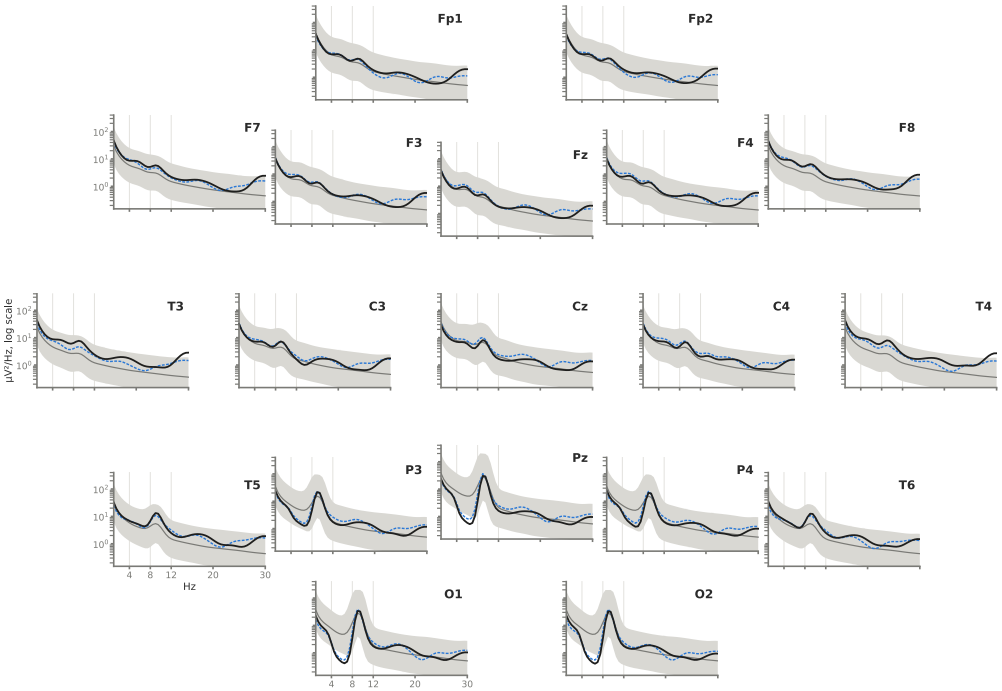
開眼時

電極ごとの絶対スペクトル, 開眼時



閉眼時

電極ごとの絶対スペクトル, 閉眼時



黒：本測定。灰色の線と帯：基準平均と平均±2 SD。青破線：過去の測定。

8. 帯域比と指数：Band ratios and indices

項目		値	基準平均	z
Czのシータ/ベータ比	開眼時	2.74	2.76	0.0
前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）	開眼時	0.03	-0.01	0.4
アルファピーク周波数（Hz）	開眼時	9.2	9.1	0.1
Czのシータ/ベータ比	閉眼時	1.95	2.82	−1.1
前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）	閉眼時	0.03	-0.01	0.4
アルファピーク周波数（Hz）	閉眼時	9.2	9.2	0.0

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

開眼時のCzにおけるシータ/ベータ比は2.74です（z = 0.0）。 TBR-1

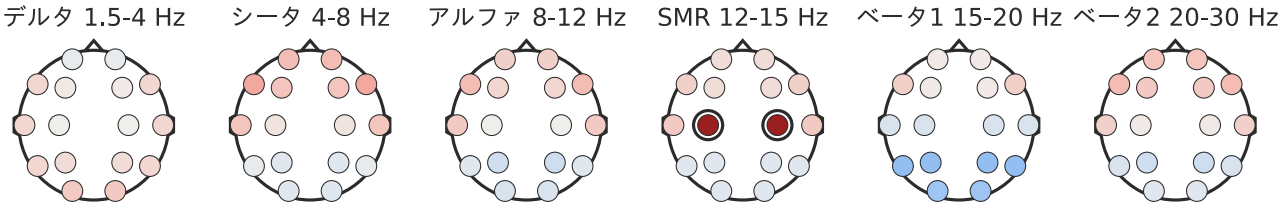
開眼時の前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）は0.03です（z = 0.4）。 FAA-1

閉眼時のCzにおけるシータ/ベータ比は1.95です（z = −1.1）。 TBR-1

閉眼時の前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）は0.03です（z = 0.4）。 FAA-1

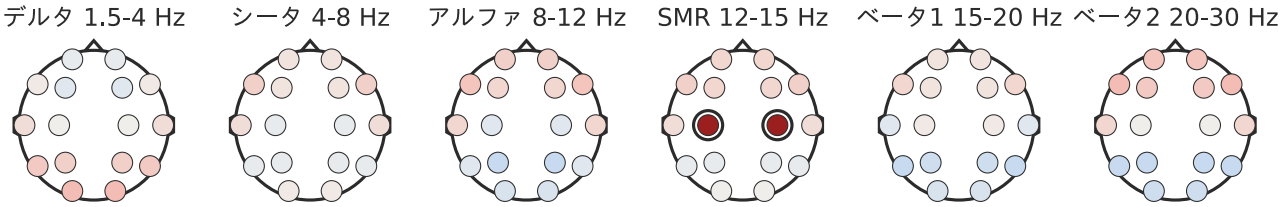
9. 左右差：Asymmetry

開眼時

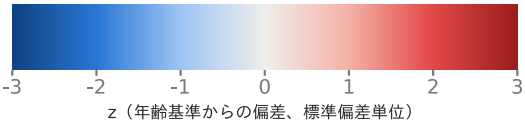


開眼時のSMR帯域の非対称指数は、C3-C4 (z = 4.2)で年齢基準より高い値です。 ASY-1

閉眼時



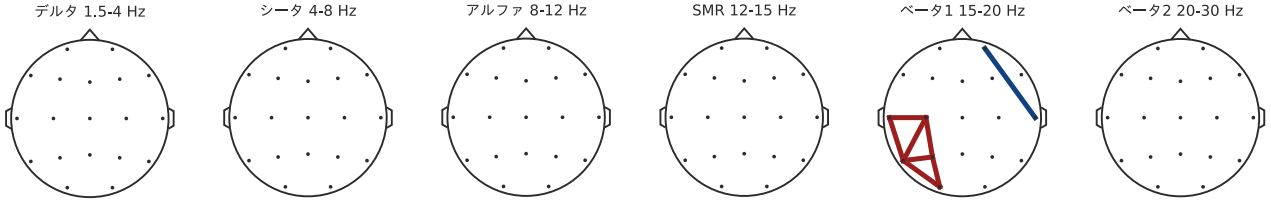
閉眼時のSMR帯域の非対称指数は、C3-C4 (z = 4.2)で年齢基準より高い値です。 ASY-1



電極ペアごとの非対称指数（右−左）／（右＋左）、年齢基準に対するz値。 輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

10. コヒーレンス：Coherence

開眼時



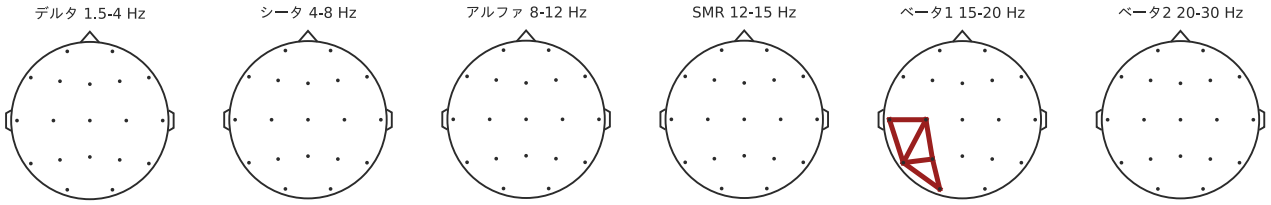
開眼時のベータ1帯域のコヒーレンスは、7組の電極ペアで年齢基準より高い値です：T3-T5 (z = 3.9)、T5-O1 (z = 3.9)、P3-O1 (z = 3.9)、T3-C3 (z = 3.8)、C3-P3 (z = 3.8)、C3-T5 (z = 3.7)、ほか1組は表を参照。 COH-1

開眼時のベータ1帯域のコヒーレンスは、1組の電極ペアで年齢基準より低い値です：Fp2-T4 (z = −3.9)。 COH-1

印の付いた電極ペア、開眼時

帯域	ベータ1							
ペア	Fp2-T4	T3-T5	T5-O1	P3-O1	T3-C3	C3-P3	C3-T5	T5-P3
コヒーレンス	0.01	0.62	0.62	0.71	0.67	0.64	0.59	0.70
z	○ −3.9	○ 3.9	○ 3.9	○ 3.9	○ 3.8	○ 3.8	○ 3.7	○ 3.7

閉眼時



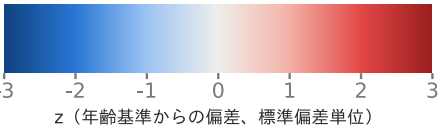
閉眼時のベータ1帯域のコヒーレンスは、7組の電極ペアで年齢基準より高い値です：T3-C3 (z = 4.1)、C3-T5 (z = 4.1)、T3-T5 (z = 4.0)、T5-O1 (z = 4.0)、P3-O1 (z = 4.0)、C3-P3 (z = 3.9)、ほか1組は表を参照。 COH-1

印の付いた電極ペア、閉眼時

帯域	ベータ1						
ペア	T3-C3	C3-T5	T3-T5	T5-O1	P3-O1	C3-P3	T5-P3
コヒーレンス	0.68	0.62	0.63	0.63	0.71	0.66	0.71
z	○ 4.1	○ 4.1	○ 4.0	○ 4.0	○ 4.0	○ 3.9	○ 3.8

グローバルコヒーレンス（全ペアの平均）、要確認

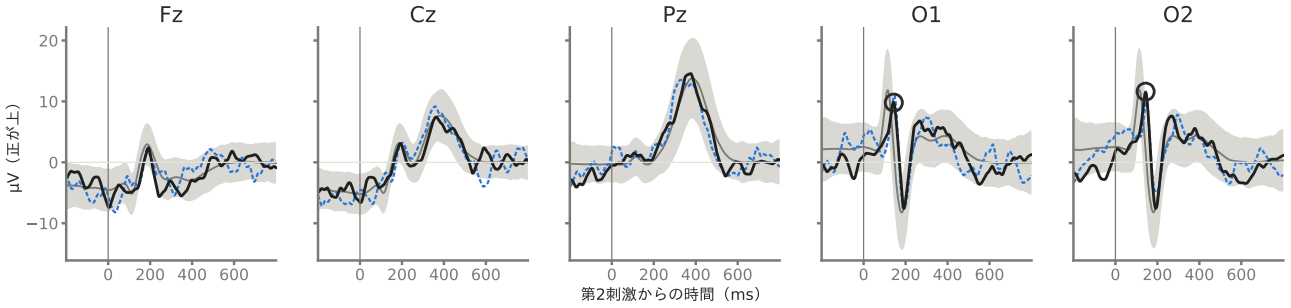
	デルタ	シータ	アルファ	SMR	ベータ1	ベータ2
開眼時、値	0.16	0.18	0.23	0.22	0.21	0.17
開眼時、z	−2.2	−1.9	−0.3	0.0	0.1	−0.6
閉眼時、値	0.18	0.19	0.24	0.22	0.21	0.19
閉眼時、z	−1.6	−1.5	−0.7	−0.1	0.1	−0.1



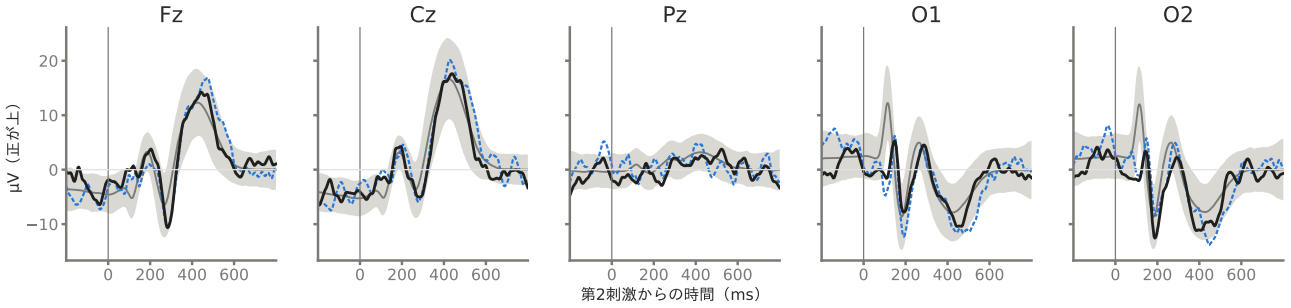
線：印の付いた電極ペア（色はz値）。 太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。 グローバルコヒーレンスは確認待ちのコア機能です。要約の順位付けの対象外です。

11. 電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）：Event-related potentials at the electrodes (channel ERPs)

電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）: Go



電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）: NoGo



黒：本測定。灰色の線と帯：基準平均と平均±2 SD。時刻0：第2刺激。 輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。 青破線：過去の測定.

ERPピーク値

成分	試行種別	電極	振幅（μV）	z	潜時（ms）	z
P1	Go	O1	9.8	−1.0	144	**o 3.7**
P1	Go	O2	11.6	−0.5	144	**o 3.7**
N1	Go	O1	-7.6	0.6	192	0.9
N1	Go	O2	-7.6	0.6	192	1.0
N2	NoGo	Fz	-10.7	−1.1	284	1.2
N2	NoGo	Cz	-5.0	−0.2	280	1.1
P3	Go	Pz	14.6	−0.1	372	−0.4
P3	NoGo	Cz	17.6	−0.2	440	0.5
P3	NoGo	Fz	14.3	0.2	444	0.6
P3a	Novelty	Cz	16.4	0.4	360	1.2
CNV	Go	Cz	-4.8	0.0	-200〜0	

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

Go試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。 ERP-PEAK-AUTO-1

NoGo試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。 ERP-PEAK-AUTO-1

Novelty試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。 ERP-PEAK-AUTO-1

Go試行のO1におけるP1潜時は、年齢基準より遅い値です（144 ms、z = 3.7）。 ERP-LAT-1

Go試行のO2におけるP1潜時は、年齢基準より遅い値です（144 ms、z = 3.7）。 ERP-LAT-1

臨床医コメント：Clinician's comment

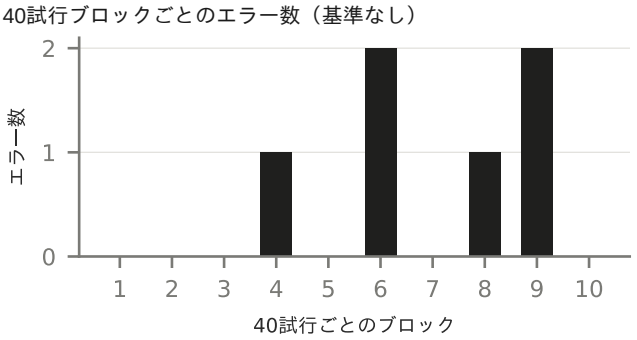
臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

12. VCPT課題の成績：VCPT task performance

認証機関の判断待ち / Subject to the certification body

項目	値	パーセンタイル	z
見逃しエラー（オミッションエラー）	2	46	−0.1
誤反応（コミッションエラー）	4	81	0.9
平均反応時間	409 ms	47	−0.1
反応時間のばらつき（SD）	86 ms	42	−0.2

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。



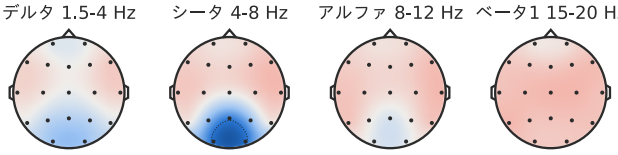
見逃しエラー（オミッションエラー）：2、印は付いていません（パーセンタイル 46）。 BEH-IN-2
誤反応（コミッションエラー）：4、印は付いていません（パーセンタイル 81）。 BEH-IN-2
平均反応時間：409 ms、印は付いていません（パーセンタイル 47）。 BEH-IN-2
反応時間のばらつき（SD）：86 ms、印は付いていません（パーセンタイル 42）。 BEH-IN-2

13. 測定の比較：Comparison of measurements

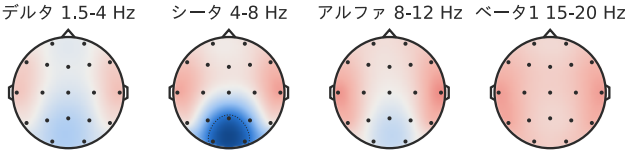
項目	過去 2026年3月12日	z	今回 2026年9月15日	z
見逃しエラー（オミッションエラー）	3	0.3	2	−0.1
誤反応（コミッションエラー）	5	1.2	4	0.9
平均反応時間	421 ms	0.1	409 ms	−0.1
反応時間のばらつき（SD）	95 ms	0.2	86 ms	−0.2
Czのシータ/ベータ比, 開眼時	2.61	−0.2	2.74	0.0
アルファピーク周波数（Hz）, 開眼時	9.1	0.0	9.2	0.1
Czのシータ/ベータ比, 閉眼時	1.93	−1.1	1.95	−1.1
アルファピーク周波数（Hz）, 閉眼時	9.1	−0.1	9.2	0.0

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

過去 2026年3月12日: 絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時



今回 2026年9月15日: 絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時



輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

開眼時のO1におけるシータ相対パワー：2026年3月12日 z = −3.8、2026年9月15日 z = −4.3。 CMP-1

開眼時のO2におけるシータ相対パワー：2026年3月12日 z = −3.7、2026年9月15日 z = −4.3。 CMP-1

閉眼時のO1におけるシータ相対パワー：2026年3月12日 z = −3.8、2026年9月15日 z = −4.3。 CMP-1

閉眼時のO2におけるシータ相対パワー：2026年3月12日 z = −3.8、2026年9月15日 z = −4.3。 CMP-1

閉眼時のT3-T5におけるベータ1コヒーレンス：2026年3月12日 z = 4.3、2026年9月15日 z = 4.0。 CMP-1

開眼時のT3-C3におけるベータ1コヒーレンス：2026年3月12日 z = 4.3、2026年9月15日 z = 3.8。 CMP-1

2026年3月12日の過去の測定は、現行のソフトウェアと基準で再解析しました（V4 mockup 0.1、Mock norms 2026.1 (synthetic)）。 L-REPROC-1

各測定はそれぞれの年齢基準と比較して並べて表示しています。測定間の差について統計的有意性は検定していません。 L-SIDE-1

14. 結果に関する注記：Notes on the results

本結果は臨床医による評価の材料の一つです。本ソフトウェアは診断を行わず、治療を推奨しません。 L-AID-1

zは、基準平均からの距離を基準集団の標準偏差で表した値です。基準集団の約95%はz = -2からz = 2の間にあります。 L-Z-1

印の付いた値は、多重比較の補正後も年齢基準と異なる値です。補正により、多数の比較の中で偶然による偏差はまれになります。印のない2 zを超える値は、偶然だけで偏差を示している可能性があります。補正方法はまだ決まっていません。 L-MC-1

15. 解釈：Interpretation

臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

16. 結論：Conclusion

臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

発行者：Issued by

発行者	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
発行日	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
版	1 · 下書き（未発行）
置き換える版	なし（初版）